中华中医药学会专家共识征求意见汇总处理表

项目名称：2 级高血压中西医结合诊疗指南　　负责起草单位：山东中医药大学附属医院、山东大学齐鲁医院

承办人：李运伦、卜培莉　　电话：13869102760　　填写日期：2022 年 9 月 30 日

意见汇总及处理情况					
序号	章条编号	提出单位和姓名	草案内容	反馈意见内容及理由	意见处理情况
1	第 1 页	北京市安贞医院/康铁朵	高血压与二级高血压分级可否用同一版指南	统一标准	未采纳。并未出自不同的指南
2	第 9 页	北京市安贞医院/康铁朵	“联合标准治疗”改“联合药物治疗”	联合标准治疗说法不规范	已采纳
3	第 16 页	北京市安贞医院/康铁朵	收缩压写两遍	笔误，可以删掉	已采纳
4	1	首都医科大学附属北京安贞医院/宁尚秋	高血压治疗目标是降低高血压的心脑肾与血管并发症发生和死亡的总危险	总危险能否改为总风险？原因是降低…风险	已采纳
5	3	首都医科大学附属北京安贞医院/宁尚秋	证据概要：一项纳入 4 项 RCT 的 META 分析显示，中药汤剂、针刺、耳穴贴压联 合常规药物治疗在降低收缩压和舒张压方面优于单纯规范降压方案	是否需要明确中药汤剂的具体名字？原因是 META 分析里面肯定有具体的中药汤剂名字，这样才具有说服力	部分采纳。如需方剂内容参考文献中可查，未提及的方剂均非经方

6	3	首都医科大学附属北京安贞医院/宁尚秋	证据概要：一项纳入 3 篇 RCT 的 META 分析结果显示，中药汤剂单独应用或联合 常规药物在收缩压、舒张压、临床疗效等方面均优于单独应用常规药物治疗，收缩压	是否需要明确中药汤剂的具体名字？原因是 META 分析里面肯定有具体的中药汤剂名字，这样才具有说服力	部分采纳。如需方剂内容参考文献中可查，未提及的方剂均非经方
7	3	首都医科大学附属北京安贞医院/宁尚秋	一项纳入 3 项RCT 的 META 分析显示，中药汤剂或针刺联合常规药物治疗，在降低 收缩压和舒张压方面优于单纯规范降压方案	是否需要明确中药汤剂的具体名字？原因是 META 分析里面肯定有具体的中药汤剂名字，这样才具有说服力	部分采纳。如需方剂内容参考文献中可查，未提及的方剂均非经方
8	3	首都医科大学附属北京安贞医院/宁尚秋	一项 META 分析显示，改善心肌损害方面，常规药物联合中成药组的左 心室质量指数均显著低于常规药物组。一项 RCT 的结果显示，依那普利联合中医药治疗 2 级高血压合并左室肥厚总有效率为 94.44%,显著高于单纯依那普利治疗。对于改善肾损伤 方面,有一项 META 分析显示，ARB、ACEI、ARB+CCB 或 CCB 联合中药治疗降低尿 10 微量白蛋白，优于单纯 ARB、ACEI、ARB+CCB 或 CCB	是否需要明确中成药组的具体名字？原因是 META 分析里面肯定有具体的中药汤剂名字，这样才具有说服力	部分采纳。如需方剂内容参考文献中可查，未提及的方剂均非经方
9	3	首都医科大学附属北京安贞医院/宁尚秋	证据概要：对于合并冠心病的患者，应用中药汤剂联合常规药物治疗对比常规药物治疗， 在控制血压、缓解冠心病症状、改善心功能上均有更好的疗效。	是否需要明确中药汤剂的具体名字？（是否是血府逐瘀汤？）原因是试验里面肯定有具体的中药汤剂名字，这样才具有说服力	部分采纳。如需方剂内容参考文献中可查，未提及的方剂均非经方
10	5.1 治疗原则	空军军医大学第一附属	其中部分有糖尿病，蛋白尿等的高危患者，更改为“其中有糖尿病，脑卒中，	更加全面的描述高危患者	已采纳

		医院/孙冬冬	心力衰竭，慢性肾脏疾病等疾病的高危患者”		
11	5.1	山东第一医科大学第一附属医院心内科/侯应龙	在陈述常用降压药分类时,是否应该增加 ARNI?以体现与时俱进	因为国家食药局已经批准诺心妥为高血压适应证	已采纳
12	5.3 临床问题 7	山东第一医科大学第一附属医院心内科/侯应龙	列举了 5 种伴随情况,是否可以删除缺乏证据的 2 种情况(心衰与肾功能不全)	在推荐意见里面只回答了冠心病,糖尿病与高脂血症,而且回答的逻辑顺序与问题中罗列的逻辑顺序不一致	未采纳。推荐意见中并未推荐缺乏证据的两种情况，临床问题为专家提出，未轻易修改
13	参考文献	山东第一医科大学第一附属医院心内科/侯应龙	对于杂志级别较低,30-50 例样本量的经验报道是否要采录,可以再斟酌	低级别杂志与小样本量文章的可信度降低,会影响整个诊疗方案的权威性与可信度	未采纳。中医类别普遍证据较低
14	2 规范性引用文件	山东中医药大学附属医院/辛义周	《中华人民共和国药典（2015 年版）》建议改为《中华人民共和国药典（2020 年版）》	新版药典已经实施 2 年，建议引用最新版本	已采纳
15	第 7 页倒数 10 行、倒数 7 行	山东中医药大学附属医院/辛义周	纳入 4 篇...和纳入 3 项...引用的文献都是 3 篇？		已采纳
16	第 9 页倒数 16 行	山东中医药大学附属医院/辛义周	“联合标准治疗”建议改为“联合常规药物治疗”	其他各处基本都是“联合常规药物治疗”	已采纳

17	第 11 页倒数 7 行	山东中医药大学附属医院/辛义周	“+常规药物治疗单独应用或”建议改为“单独应用或”或删掉，需要根据文献内容	跟前后文的表述不一致	已采纳
18	第 12 页正数 6 行、7 行、8 行，倒数 9 行、10 行、11 行	山东中医药大学附属医院/辛义周	“枸杞”建议改为“枸杞子”,“生石决”建议改为“石决明”,“生杜仲”建议改为“杜仲”,“白菊花”建议改为“菊花”	按照药典，枸杞子是规范名称，写石决明、杜仲就是指生品，无需注明“生”，药典无白菊花的说法。	已采纳
19	第 14 页上边第 10 行、倒数第 8 行	山东中医药大学附属医院/辛义周	“芍药”建议明确为”白芍”或”赤芍”,“生龟板、生代赭石、生龙骨、生牡蛎、生麦芽”建议去掉“生”	药典无芍药的说法，按照药典，这些药品如果是生品，无需标记“生”。	已采纳
20	第 15 页上边第 5 行，第 17 行，倒数 11 行，倒数 6 行	山东中医药大学附属医院/辛义周	5 行的“生地”建议改为“生地黄”、17 行 MD=-3.47,95%CI [-12.35,5.42]是否有误？倒数 11 行“干地黄”，有鲜地黄、生地黄、熟地黄，没有干地黄的说法，倒数 6 行的 OR=2.67，95% CI [3.76，5.89]是否有误？		已采纳
21	第 16 页倒数 10 行	山东中医药大学附属医院/辛义周	两个“收缩压”，可删去一个		已采纳

22	5.3 临床问题	中国中医科学院西苑医院/高蕊		临床问题 3：2 级高血压患者，可否联用中医药疗法协助控制血压？推荐意见 1:2 级高血压(中危）患者，在常规药物治疗的基础上,联用中医药疗法以 协助控制血压。辨证加用中药汤剂（补益肝肾方),合理配合中医适宜技术（针刺、耳穴贴 压）以提高疗效。(证据级别：C 级 推荐强度：强推荐)，一般情况下，证据级别 C 很难强推荐，推荐的理由需要解释，另外需要明确是哪一个措施强推荐，药汤剂（补益肝肾方）？针刺？耳穴贴压？不应该都是强推荐	未采纳。强推荐为专家投票所得推荐意见，上述内容专家均审阅
23	5.3 临床问题	中国中医科学院西苑医院/高蕊		推荐意见 4：2 级高血压（很高危）患者在血压增高的同时已经伴发了临床疾病，在常规药物治疗的基础上，辨证联用中药汤剂（半夏白术天麻汤），以提高疗效。(证据级别：C 级 推荐强度：弱推荐。这个临床问题疗效结果表述不清晰，干预措施是针对伴发疾病的还是针对高血压的，如果针对高血压的，已经有相关条目了，如果针对伴发疾病的，疗	未采纳。虽针对高血压，但针对的是很高危分层的患者

				效指标不吻合，请解释确认	
24	5.3 临床问题	中国中医科学院西苑医院/高蕊		临床问题 5：2 级高血压患者血压波动大者，是否适宜常规药物联合中医药疗法协助降 压？ 推荐意见 1：2 级高血压（中危）患者血压波动大，在常规药物治疗的基础上,辨证联 用中药汤剂（石决牡蛎汤）以平稳降压。(证据级别:D 级 推荐强度:强推荐。证据级别 D 强推荐需慎重，并解释原因	未采纳。强推荐为专家投票所得推荐意见，上述内容专家均审阅
25	5.3 临床问题	中国中医科学院西苑医院/高蕊		推荐意见 2：2 级高血压（中/高危）患者已合并危险因素，对于血压波动大的 2 级高血 压（中/高危）患者，在常规药物治疗基础上，可辨证联用中药汤剂（钩藤四物汤、活血柔 肝方）以平稳降压。(证据级别：D 级 推荐强度：强推荐。证据级别 D 强推荐需慎重，并解释原因	未采纳。强推荐为专家投票所得推荐意见，上述内容专家均审阅
26	5.3 临床问题	中国中医科学院西苑医院/高蕊		临床问题 11:中成药适宜干预 2 级高血压患者吗？，这个临床问题太大，不是所有的中成药都适合高血压患者，建议回归品种论述	未采纳。所列举中成药均于编制说明中列举，且已推荐重点药物

	5.3 临床问题	中国中医科学院西苑医院/高蕊		临床问题 12：中医经典方剂（柴胡疏肝散、天麻钩藤饮、镇肝熄风汤、半夏白术天麻 汤、血府逐瘀汤合涤痰汤、六味地黄丸、肾气丸)适宜协助干预 2 级高血压患者吗。有些处方前面已经提到了，并推荐了，再问是重复的，有些没有提到的处方需要单独论述，不应该合在一起。	未采纳。前面的方剂并未按证型进行有效推荐
27	5.3 临床问题	中国中医科学院西苑医院/高蕊		整体指南存在证据级别不高，强推荐过多的情况，建设慎重评估解释	
28	P6 以后	南京中医药大学附属医院/严冬	多处证据级别与推荐强度不匹配（如：证据级别：D 级 推荐强度：强推荐）	没有依据 GRADE	未采纳。强推荐为专家投票所得推荐意见，上述内容专家均审阅
29	P7	南京中医药大学附属医院/严冬	推荐意见 2 辨证联用中成药(复方丹参滴丸)中“辨证”是否应该为具体证型（比如血瘀证）。文中还有多处类似的情况	因为复方丹参滴丸是有明确功效的，因而具有特定证型。另外在推荐说明里需要就推荐该药的症状作详细说明。其它有中成药的地方建议一并修改，保证药证配合，减少使用误区。	未采纳。为格式统一
30	P14	南京中医药大学附属医院/严冬	柴胡舒肝散只有一个临床研究	临床上这种超早期的肝郁较难在 2 级高血压中持续看到，要不已经化火，要不就是阳亢。柴胡疏肝散中的药物成分特别是芸香科属的	未采纳。证据确实欠充分，但已经专家论证 中药的组方配伍可减轻化燥伤阴的作用

				易化燥伤阴，升高血压，不适合临床长期使用。	
31		南京中医药大学附属医院/严冬	建议用中药成方或者中成药均说明适用的症状，方证对应，减少非中医专业人士使用方案时的误解。 中药复方的使用时间、方法、什么时候调整药方是否要另外加以说明，甚则有时需要将用量也要写个范围，因为基于西医的认识，都是以 1g 一下作为用量单位，所以临床常见西医用中成药经常 1 粒 1 次，这样不会发挥中药的应有作用，还留下中医中药没用的坏名声		部分采纳。用法用量已经完善，对于克为单位，不适用于中成药（中成药多数以粒或者袋为规格）
32	6 诊疗流程图	中国中医科学院广安门医院/吴敏	“中医意愿强烈”患者建议增加“中医适宜技术”	临床中这部分患者采用中药汤剂+中医适宜技术，临床疗效较好	未采纳。无证据
33	1	辽宁中医药大学附属医院/刘彤	本诊疗方案适合各级医疗机构中从事高血压临床工作的相关人员使用	建议考虑西医临床医生是否合适	未采纳。过于局限
34	4.1.3	辽宁中医药大学附属医院/刘彤	表（2）血压后应加 mmHg，	血压后应有单位，更严谨	已采纳
35	4.1.3	辽宁中医药大学附属医院/刘彤	表（2）第一列罗马数字建议删除	更简洁	已采纳
36	4.1.3	辽宁中医药大学附属医	表（1）表（2）后建议加备注表（1）注：以上诊断标准适用于成人，当收缩压和	更严谨	已采纳

		院/刘彤	舒张压分属于不同级别时，以较高级别作为标准。表（2）注：CKD,慢性肾脏疾病。		
37	5.3	辽宁中医药大学附属医院/刘彤	辨证加用中药汤剂（补益肝肾方）建议去掉（补益肝肾方）	辨证加用中药汤剂表述更严谨，或（）内多加几个方子，避免错觉为都用补益肝肾方。	已采纳
38	5.3	辽宁中医药大学附属医院/刘彤	辨证联用中药汤剂（枸杞子、女贞子、杜仲、天麻、钩藤、牛膝、鸡血藤）/中成药（复方丹参滴丸）	表述不严谨中药汤剂括号内均为中药饮片，中成药括号推荐药物单一容易误解。建议修订。	已采纳
39	5.3	辽宁中医药大学附属医院/刘彤	辨证联用中药汤剂（半夏白术天麻汤）/中成药（血府逐瘀胶囊）	临床问题3-5表述有些凌乱不太清楚，建议重新归纳总结。建议辨证联用改为某证用某方，因为荟萃分析用的研究也是针对具体证型。	部分采纳。荟萃分析用的研究针对具体证型，但该临床问题并不针对具体证型，只是有该证型的证据
40	5.3临床问题5	辽宁省人民医院/王胜勇	血压波动大可以进一步概括为血压变异性大	研究显示，血压变异性大为心血管事件增高的独立危险因素，降压血压的变异性也是中医药实现高质量降压的一个体现	已采纳
41	5.3临床问题8	辽宁省人民医院/王胜勇	老年单纯收缩期高血压在联合中医药治疗时要避免体位性低血压及餐后低血压，同时避免舒张压过度下降	老年人血压波动大，单纯收缩期高血压多见，降压过程中容易出现体位性低血压及餐后低血压，而舒张压过度下降会影响冠脉供血，因	已采纳

				此需要加强血压的监测	
42	5.3 临床问题 9	辽宁省人民医院/王胜勇	若无危险因素，主观意愿强烈要求用中药的患者，需要设置一个降压时限，比如 4-6 周，若经过该时间的治疗，患者血压控制仍然不理想，则需要及时联用西药降压	降压达标并不是无限期的。研究显示，早期降压达标（4 周左右）能够更有效的降低终点事件，改善预后	已采纳
43	5.3 临床问题 10	辽宁省人民医院/王胜勇	联合中医药时减/撤西药需要格外慎重	总体来看，高血压是个进展性疾病，某一阶段的血压控制良好并不代表长期的血压控制，因此减/撤西药时需要密切监测血压，良好的评估。降压达标是准绳，而不是以减药、撤药为标准	已采纳
44	5.1 治疗原则	辽宁省人民医院/王胜勇	血压测量方面的建议	除了诊室血压外，需要引入 24 小时动态血压和家庭自测血压，这有助于了解血压的具体情况和评估治疗的效果	已采纳
45	5.1 治疗原则	辽宁省人民医院/王胜勇	2 级高血压的降压达标时间	高血压需要在 4-6 周内将患者的血压控制在目标范围内。一方面血压早期达标有利于减少终点事件，另一方则有助于提升患者的治疗依从性	已采纳
46	总体的治疗方	辽宁省人民医院/王胜勇	需要加入治疗过程中安全性、副反应方面的内容	任何一种治疗方案都是双刃剑，中医药也是一样。	已采纳

	案				
47	P4，4.2	湖南中医药大学中西医结合学院/邓常清	建议适当增加高血压常见的证候	中医诊疗指南中有7个常见证候，如气血两虚证等，而本指南中未包括这些证候，是否应当要包括这些证候？	未采纳。已经专家讨论，气血两虚证所致高血压临床较少
48	P6,临床问题3	湖南中医药大学中西医结合学院/邓常清	推荐意见2、3推荐强度建议修改	推荐意见1、2证据级别均为C级，推荐强度均为强推荐，依据不充分。	未采纳。强推荐为专家投票所得推荐意见，上述内容专家均审阅
49	P7,临床问题4	湖南中医药大学中西医结合学院/邓常清	推荐意见1、2、3推荐强度建议修改	推荐意见1、2、3证据级别均为C级，推荐强度均为强推荐，依据不充分。	未采纳。强推荐为专家投票所得推荐意见，上述内容专家均审阅
50	P8,临床问题5	湖南中医药大学中西医结合学院/邓常清	推荐意见1推荐强度建议修改	推荐意见1证据级别为D级，推荐强度为强推荐，依据不充分。	未采纳。强推荐为专家投票所得推荐意见，上述内容专家均审阅
51	P9,推荐意见2	湖南中医药大学中西医结合学院/邓常清	推荐意见2推荐强度建议修改	推荐意见2证据级别为D级，推荐强度为强推荐，依据不充分。	未采纳。强推荐为专家投票所得推荐意见，上述内容专家均审阅
52	P9,临床问题6	湖南中医药大学中西医结合学院/邓	推荐意见的推荐强度建议修改	推荐意见的证据级别为B级，推荐强度为弱推荐，似乎不合理。	未采纳。强推荐为专家投票所得推荐意见，上述内容专家均审阅

		常清			
53	P11，临床问题8	湖南中医药大学中西医结合学院/邓常清	推荐意见的推荐强度建议修改	推荐意见的证据级别为C级，推荐强度为强推荐，依据不充分。	未采纳。强推荐为专家投票所得推荐意见，上述内容专家均审阅
54	P12，临床问题12	湖南中医药大学中西医结合学院/邓常清	推荐意见1的推荐强度建议修改	推荐意见1的证据级别为C级，推荐强度均强推荐，依据不充分。	未采纳。强推荐为专家投票所得推荐意见，上述内容专家均审阅
55	P14，临床问题12	湖南中医药大学中西医结合学院/邓常清	推荐意见2、3、4的推荐强度均建议修改	推荐意见2、3、4的证据级别均为C级，推荐强度均为强推荐，为什么？是否是根据专家共识？如果是以专家共识为依据的话，推荐意见5、6、7也应当为强推荐，这样才符合中医的辨证论治原则。	未采纳。强推荐为专家投票所得推荐意见，上述内容专家均审阅
56	P15，临床问题13	湖南中医药大学中西医结合学院/邓常清	推荐意见1的推荐强度建议修改	推荐意见1的证据级别为B级，推荐意见为弱推荐，不合理，建议改为推荐，针刺疗法是有明确的效应的。	未采纳。强推荐为专家投票所得推荐意见，上述内容专家均审阅
57	P16，推荐意见3（中药足浴疗法）	湖南中医药大学中西医结合学院/邓常清	推荐意见3的推荐强度建议修改	推荐意见3的证据级别为B级，推荐意见为弱推荐，不合理，建议改为推荐，中药足浴疗法是可以作为高血压的辅助治疗方法的。	未采纳。强推荐为专家投票所得推荐意见，上述内容专家均审阅

58	P16，推荐意见4（太极拳）	湖南中医药大学中西医结合学院/邓常清	推荐意见4的推荐强度建议修改（证据的依据）	推荐意见4的证据级别为C级，推荐意见为强推荐，为什么？太极拳对高血压是有较好的辅助治疗作用的，虽然证据级别较低，但这是目前的共识，根据共识，可以强推荐或推荐。	未采纳。强推荐为专家投票所得推荐意见，上述内容专家均审阅
59	3.1	广西国际壮医医院/姜益宏	来源：《国家基层高血压防治管理指南（2020版）》 建议更改为或增加： 来源:《中国高血压防治指南(2018年修订版)》	与3.2、4.1.1体例行文前后统一	已采纳
60	4.1.3	广西国际壮医医院/姜益宏	建议增加具体的心血管危险因素、靶器官损害、伴发临床损害表格，可参考《中国高血压防治指南（2018年修订版）》	作为高血压危险水平分层的重要依据	已采纳
61	4.2.5	广西国际壮医医院/姜益宏	头痛、胸痛、四肢麻木、心悸、口干、头晕 建议改为：头痛、头晕、胸痛、四肢麻木、心悸、口干； 诊断要点：头痛头重 应该为：头痛、头晕	主要症状靠前 上下行文一致	已采纳
62	5.1	广西国际壮医医院/姜益宏	对于2级高血压患者，建议优先选择常规药物降压方案；但对于常规药物治疗基础上，存在未控制到目标血压、症状改善不明显、血压波动大等问题，可联合中医药疗法（中药汤剂、中成药和中医适宜技术等）协同治疗。另外，结合中医理论指导生活方式进行养生调摄，从而增强疗效，提高血压达标率。 建议更改为：对于2级高血压患者，建议结合	生活方式治疗是所有高血压的基础治疗，优先选择常规药物降压方案有歧义；中医在改善生活方式治疗上有独特优势，应当发挥特色予以强调。	未采纳。《中国高血压防治指南(2018年修订版)》中真对级高血压已建议尽早联合用药

			中医理论指导生活方式进行治疗及养生调摄,如调整饮食结构、改善起居方式、导引运动等形式的基础上选择常规药物降压方案;但对于上述治疗基础上,存在未控制到目标血压、症状改善不明显、血压波动大等问题,可联合中医药疗法(中药汤剂、中成药和中医适宜技术等）协同治疗。中西医结合治疗 2 级高血压仍需遵循中医理论,强调整体观念和辨证论治,注重个体化治疗。		
63	5.3	广西国际壮医医院/姜益宏	临床问题中对应的方药推荐是否加上对应的证型	保证理法方药一致性	部分采纳。有证据的均补充上
64	引用相关标准 1	广西国际壮医医院/姜益宏	《国家基层高血压防治管理指南（2020 版）》诊断标准建议更改或增加《中国高血压防治指南（2018 年修订版）》	两者诊断标准一致，保证前后行文一致	已采纳
65	4.1.3 危险分层	广西国际壮医医院/徐先增	应附有参考文献出处	重要内容应附有参考文献	已采纳
66	4.1.3 危险分层	广西国际壮医医院/徐先增	中/高危是否应该作为独立危险分层值得推敲	中/高危不是低危、中危、高危、很高危其中的一种	未采纳。指南中明确指出
67	5.3 临床问题	广西国际壮医医院/徐先增	一项纳入 4[11, 13, 14]篇 RCT 的 META 分析结果显示,应该有 4 篇参考文献	数量不对	已采纳
68	4.3	新疆医科大学附属中医医院/李鹏	临床问题 1：2 级高血压患者的常见证候类型，建议补充心肾阴虚型	高血压患者的常见中医证候类型存在一定的地域差异，心肾阴虚证是新疆地区	未采纳。专家投票得出

				高血压患者的常见证型之一	
69	5.3.2	新疆自治区乌鲁木齐市中医医院/邓德强	后者包括限盐、限酒、……　加入控糖、低脂饮食	高糖、高脂饮食是目前代谢综合征的主要原因	已采纳
70	5.3.3	新疆自治区乌鲁木齐市中医医院/邓德强	辨证加用中药汤剂（补益肝肾方）疑问	辨证为痰湿壅盛证、痰瘀互结证也用“补益肝肾方”？	已采纳
71	5.3.4	新疆自治区乌鲁木齐市中医医院/邓德强	辨证联用中药汤剂（半夏白术天麻汤）疑问	辨证为肝火亢逆证或阴阳两虚证也用“半夏白术天麻汤”？	未采纳。仅列举有证据的内容
72	5.3	新疆自治区乌鲁木齐市中医医院/邓德强	临床问题条目下，序号错误，无问题 1		未采纳。问题 1 已按照体例进行编号
73	4.2	新疆自治区乌鲁木齐市中医医院/邓德强	症候诊断下建议给出建议方剂		已采纳
74	4.1.3	黑龙江中医药大学附属第二医院/叶婷	“根据血压水平、心血管危险因素、靶器官损害、临床并发症和糖尿病进行心血管风险，分为低危、中危、高危和很高危 4 个层次”，表述不当。建议：“根据血压水平、心血管危险因素、靶器官损害、临床并发症和糖尿病进行心血管危险分层，分为低危、中危、高危和很	人民卫生出版社第 9 版《内科学》中表述为“危险分层”。	已采纳

			高危 4 个层次。”		
75	4.2	黑龙江中医药大学附属第二医院/叶婷	4.2 证候诊断中各症状之间是否“,”为宜，例如：4.2.1 肝郁气滞证 头晕、头痛、头胀、胸闷、胁胀或痛、情志抑郁或易怒、善太息、纳呆、痞满、腹部胀满，舌淡苔薄白、脉弦。表述为：头晕，头痛，头胀，胸闷，胁胀或痛，情志抑郁或易怒，善太息，纳呆，痞满，腹部胀满，舌淡苔薄白，脉弦。	“十四五”《中医内科学》对症状描述中表述，各症状间用“,”。	未采纳。均可，行文格式统一即可
76	4.2	黑龙江中医药大学附属第二医院/叶婷	4.2 中各证型间见到相同症状是否统一表述更合适，例：4.2.1 肝郁气滞证 头晕、头痛、头胀。4.2.2 肝火亢逆证 头胀痛、头晕。是否统一表述为：“头胀痛、头晕”。舌脉的描述是否更统一一些为好，例：舌脉表述统一格式“舌质（ ），苔（ ），脉（ ）”。	表述统一，更具有严谨性。	未采纳。均可，行文格式统一即可
77	5.3 临床问题 7	黑龙江中医药大学附属第二医院/叶婷	“推荐意见 1：2 级高血压（很高危）患者中伴发高脂血症者”，表述为“推荐意见 1：2 级高血压（很高危）合并高脂血症患者”，是否更为得当？推荐意见 2 和推荐意见 3 的表述也推荐上面建议。	与下面的推荐说明的表述一致。	已采纳
78	5.3 临床问题 14	黑龙江中医药大学附属第二医院/叶婷	推荐意见 1，中对针刺疗法的推荐“每周 2 至 3 次，4 周为一个疗程。”，每周 2 至 3 次的频率是否合适。	临床中针灸通常每周至少 5 至 6 次。	未采纳。不适合临床

79	5.3	黑龙江中医药大学附属第一医院/蒋宁	高血压合并肾脏疾病时，是否可以联用中药方剂。	临床问题 7 涉及该内容，但缺乏相关结论。	未采纳。缺乏相关证据，后续修订时补充
80	5.3	黑龙江中医药大学附属第一医院/蒋宁	如果高血压合并肾脏疾病时，可以联用中药方剂，具体有哪些，以及相关证据。	中国高血压防治指南 2018 年等指南对于高血压合并肾脏疾病患者的治疗和治疗目标均不同于普通患者。	未采纳。缺乏相关证据，后续修订时补充
81	5.3	黑龙江中医药大学附属第一医院/蒋宁	是否增加高血压合并代谢综合征相关内容	相关指南特殊人群高血压的处理一般包括糖尿病及代谢综合征相关内容。	未采纳。缺乏相关证据，后续修订时补充
82	5.3 临床问题 11	长春中医药大学附属医院/王健	推荐意见 2 珍菊降压片应补充完善功能主治	治疗高血压的中成药种类繁多，因此每种中成药的药物组成、功能、适用人群（症状）的说明至关重要。	未采纳。已包括
83	5.3 临床问题 12	长春中医药大学附属医院/王健	推荐意见 1 改为弱推荐	证据概要中只纳入 1 篇 RCT 研究，证据等级稍低。	未采纳。根据检索证据如实填写
84	5.3	长春中医药大学附属医院/王健	临床问题 3，推荐 1，“补益肝肾方”改为“调补肝肾”。	临床证型里肝郁、肝阳上亢。。。以实证居多，补益肝肾方主要用于虚证，感觉前后不一致。调补肝肾，虚实均兼顾。	未采纳。原文内容为“补益肝肾方”
	5.3	长春中医药大学附属医院/邓悦	第 11 页，“P=0.000”可统一为“P<0.001”	统计学行文习惯	已采纳

85	5.1	长春中医药大学附属医院/邓悦	第 5 页，“β”的字体与整体不统一	字体问题	已采纳
86	5.3	长春中医药大学附属医院/邓悦	中成药应注明详细的规格	明确中成药用量需要规格信息	已采纳
87		浙江中医药大学/季旭明	优化语言		已采纳
88	5.3	浙江中医药大学/季旭明	太极拳应注明每周的频次		已采纳
89	引言第一段	浙江中医药大学/季旭明	2002-2015 年进行了三次全国高血压抽样调查研究，结果显示中国居民高血压患病率呈上升趋势[1]。	对比 2002-2015 年间进行的三次全国性高血压抽样调查研究显示，中国居民高血压患病率呈逐渐上升趋势[1]。	已采纳
90	引言第一段	山东第一医科大学第一附属医院/李欣然	控制 2 级高血压在高血压靶器官损害及并发症防治方面具有积极的价值。	因此，及时、有效地控制 2 级高血压对于改善高血压靶器官损害及防止并发症等方面均具有积极的价值。	已采纳
91	临床问题 1	山东第一医科大学第一附属医院/李欣然	多空格	删掉空格	已采纳
92	3.2	山东第一医科大学第一附属医院/李欣然	多一个空格	删掉空格	已采纳
93	参考文献 21、37、43、	江苏省中医院/王永生	格式对齐		已采纳

	63				
94	编制说明	江苏省中医院/王永生	主审专家陈玉国教授需要补充		已采纳
95		江苏省中医院/王永生	疾病领域专家多句号		已采纳
96	定义临床问题	石家庄平安医院/黄怀鹏	参考文献5、6上标		已采纳
97		石家庄平安医院/黄怀鹏	正常血压正常高值血压范围中括号		已采纳
98		石家庄平安医院/黄怀鹏	调整一下附件七各种表格的格式，争取基本一致		已采纳
99		石家庄平安医院/黄怀鹏	修改编制说明中附件七标题	附件七标题与前面不一致	已采纳
100	4.2.1	石家庄白求恩国际和平医院/李庆华	“头晕、头痛、头胀、胸闷、胁胀或痛、情志抑郁或易怒、善太息、纳呆、痞满、腹部胀满，舌淡苔薄白、脉弦。”前增加“常见症状”		已采纳
101	5.1	石家庄白求恩国际和平医院/李庆华	“结合中医理论指导生活方式进行养生调摄,如调整饮食结构、改善起居方式等形式,从而增强疗效，提高血压达标率。”前增加“在生活方式指导的基础上”		已采纳
102	5.1	石家庄白求恩国际和平医院/李庆华	“常用降压药物包括钙通道阻滞剂、血管紧张素转化酶抑制剂、血管紧张素受体拮抗剂、利尿剂和β受体阻滞剂五类,以及由上述药物组成的固定配比复方制剂。”是否增加诺欣妥		已采纳
103		南京中医药	“对于伴冠心病、糖尿病、心衰、肾功能不全、		已采纳

		大学附属医院/常诚	高脂血症等疾病的2级高血压（很高危）患者，是否联用中医药疗法协助降压？”是否修改相关疾病种类		
104		南京中医药大学附属医院/常诚	“血府逐瘀汤合涤痰汤具有行气化痰、活血化瘀”是否调整顺序		已采纳
105	4.3	南京中医药大学附属医院/常诚	“共检索144篇文献，其中流行病学调查141篇，专家共识3篇，结果显示：肝郁气滞证：20篇”改为“141篇文献共20篇包含肝郁气滞证”		已采纳
106	3.1与3.2	首都医科大学附属北京中医医院/尚菊菊	高血压和2级高血压的定义建议参考同一个指南		已采纳
107	第6页	首都医科大学附属北京中医医院/尚菊菊	中医药疗法是个大的概念，里面写了中药汤药：辨证加用中药汤剂（补益肝肾方），合理配合中医适宜技术（针刺、耳穴贴压）以提高疗效、之后的每个问题，高血压的推荐意见，建议把文献的辩证分型写出来	前面有6型中不单是肝肾不足，或肝肾阴虚证，所以建议括号里面的补益肝肾方去掉。中医适宜技术建议加个“等”字，中医适宜技术有好多，比如足浴也可以辅助降压	部分采纳。涵盖的已修改
108	第13页	首都医科大学附属北京中医医院/尚菊菊	“推荐意见2：珍菊降压片可协助治疗2级高血压”。建议加上2级高血压的中医证型		未采纳。统一放在了功能主治中
109	第15页	首都医科大学附属北京中医医院/尚菊菊	临床问题13：中医适宜技术（针刺、耳穴贴压、足浴、太极拳） 建议全文的中医适宜技术统一		未采纳。根据证据填写

110	第 17 页	首都医科大学附属北京中医医院/尚菊菊	诊疗流程图中里面的中药汤剂，中成药是和的关系还是或的关系		未采纳。根据证据填写
111	诊断	内蒙古自治区人民医院/斯琴高娃	需要添加高血压合并心理问题的中西医诊断	心理问题明显影响血压水平。	未采纳。根据指南填写
112	治疗	内蒙古自治区人民医院/斯琴高娃	1.高血压合并心理问题的中西医诊断明确时，除了中西医药物治疗外，也推荐中西医心理治疗。	● 心理治疗包括认知行为治疗、正念减压放松治疗、运动治疗、音乐治疗等明显减低血压水平。 ● 中医也有情志治疗等等。	未采纳。根据指南填写
113		内蒙古自治区人民医院/斯琴高娃	2.高血压的营养指导与治疗也可以降低血压。	比如高盐高脂肪饮食及肥胖都会影响血压。	部分采纳。根据指南填写
114		内蒙古自治区人民医院/斯琴高娃	3.高血压是否合并 OSA 病因治疗	OSA 也影响血压	未采纳。根据指南填写
115	13 页	内蒙古医科大学附属医院/韩额尔德木图	珍菊降压片等是否谨慎选择呢？	成分中有可乐定,氢氯噻嗪等	未采纳。根据指南填写
116	17 页	内蒙古医科大学附属医院/韩额尔德木图	诊治流程图！	可能个人的理解问题，总觉得有进一步完善的空间	未采纳。根据指南填写

117	13 页	内蒙古医科大学附属医院/韩额尔德木图	怎么提高患者的依从性，减低经济负担？	我是蒙医学临床医生，临床中应用过松龄血脉康，从患者角度考虑实属不易，口服次数多以及经济负担也不小。	未采纳。根据证据填写
118	无	空军军医大学第一附属医院/刘海涛	无	内容详实，证据可靠	
119	临床问题 1	应急总医院/常富业	无	临床来看，基本上分为该六型。	已采纳
120	临床问题 2	应急总医院/常富业	无	中医养生调摄等方法以协助降压，对于个体的高血压管理不可或缺。所谓控制血压就是生活，作为个体生活的一部分，养生调摄非常重要。	已采纳
121	临床问题 3	应急总医院/常富业	无	2 级高血压患者，联用中医药疗法，有助于消除各种因素带来的血压不稳定，有助于平稳降压，减缓或消除血压波动带来的各种症状和体征。	
122	临床问题 4	应急总医院/常富业	无	2 级高血压患者，往往在血压波动时期，出现头晕、头痛等不适症状，在常规西医治疗基础上，联用中医药疗法可有效缓解患者不适症状。	

123	临床问题 5	应急总医院/常富业	无	对于 2 级高血压患者血压波动大者，在常规西药控制血压的基础上，联合中医药疗法能有效地解除各种病因带来的血压波动，缓解患者的各种不适症状。	
124	临床问题 6	应急总医院/常富业	无	对于 2 级高血压（高危）患者，联用中医药疗法能有效防治靶器官损伤。	
125	临床问题 7	应急总医院/常富业	无	对于伴冠心病、糖尿病、心衰、肾功能不全、高脂血症等疾病的 2 级高血 压（很高危）患者，可以联用中医药疗法协助降压，同时能有效缓解或消除所伴有疾病的多种症状。	
126	临床问题 8	应急总医院/常富业	无	2 级单纯收缩期高血压患者，联合中医药疗法有助于协助降压，改善动脉硬化的临床症状，延缓靶器官损伤的病理过程。	
127	临床问题 9	应急总医院/常富业	无	对于中医药疗法意愿强烈的 2 级高血压患者，可联用中医药疗法以协助控制血压，不仅增强患者控制高血压的信心，同时有助于提高控制高血压各种手段的依从性，提高西药降压的效果。	
128	临床问题 10	应急总医院/常富业	无	对于 2 级高血压患者，与常规治疗相比，联合中医药有助于缩短	

				血压控制达标的时间，有助于尽快缓解或消除高血压的症状和体征，有助于消除长期应用西药所带来的用药恐惧，有助于减少西药的用量或用药种类。	
129	临床问题 11	应急总医院/常富业	无	中成药适宜干预 2 级高血压患者，有助于减少西药降压药物的用量和种类，而且依从性高。	
130	临床问题 12	应急总医院/常富业	无	在辨证施治的基础上，中医经典方剂（柴胡疏肝散、天麻钩藤饮、镇肝熄风汤、半夏白术天麻 汤、血府逐瘀汤合涤痰汤、六味地黄丸、肾气丸）同样适宜干预 2 级高血压患者，具有整体调节、依从性高，消除临床症状或体征快，减缓并发症发生的特点。	
131	临床问题 13	应急总医院/常富业	无	在西药控制血压的基础上，中医适宜技术（针刺、耳穴贴压、足浴、太极拳）适宜干预 2 级高血压患者，有助于控制血压的自我管理，平稳降压，避免血压的波动，提高降压效果。	
132		山东宏济堂制药集团股份有限公司/孟兆青	无意见		
133	/	浙江中医药	无	该标准证据充分，制定合	

		大学/万海同		理，符合临床2级高血压诊疗需要。	